

認知バイアスが診断推論を歪める

— 行動経済学からの処方箋

20 分 | 研修医・専攻医向け | ガニエ事象 1: 注意の獲得

「完全に確信がある」と答えた医師の
40% が間違っていた —— ICU 剖検研究

これは能力の問題ではない。人間の脳に構造的に組み込まれた
「予測可能なシステムエラー」である。

学習目標

1

認識できる

4 つの認知バイアス（確認・アンカリング・
利用可能性・過信）を臨床場面で見分けられる

2

実践できる

除偏介入を 3 つ使える
（診断タイムアウト・プレモーテム・構造化振り返り）

3

振り返れる

自分の推論プロセスを
構造化して省察できる

二重過程理論 — System 1 と System 2

System 1 (直感)

高速・自動的・省エネ
パターン認識で即座に診断仮説を生成
強み: 経験に基づく効率的判断
弱み: 認知バイアスの温床

System 2 (分析)

低速・意識的・高負荷
鑑別診断リストの体系的検討
強み: 論理的・確率的推論
弱み: 疲労で機能低下

2,500 以上の論文がこのモデルを医療に適用

Enke (2023): 命がかかっている場面でもバイアスは縮小するが完全には消えない

確認バイアス — 自分の仮説を裏づける情報ばかり集める

臨床ケース：不安障害既往の胸痛

32 歳女性。不安障害の既往あり。胸痛を主訴に来院。

1. バイアス発動：「不安障害の既往」→ System 1 が「パニック発作」を生成
2. 確認的情報収集：「ストレスは？」「動悸は？」 — 支持する質問が優先
3. 矛盾情報の軽視：軽度の頻脈、SpO2 96% を「不安による」と解釈
4. 結果：肺塞栓症の見逃し

エラーの構造：既往歴がアンカーとなり、確認バイアスが強化する複合パターン

アンカリング — 最初の情報に引きずられる

臨床ケース：紹介状バイアス

58 歳男性。紹介状に「逆流性食道炎の増悪疑い」と記載。

1. アンカー設定：紹介状の診断名が System 1 に即座に取り込まれる
2. 不十分な調整：労作時増悪、冷汗 — GERD に一致しない点に注意が向きにくい
3. 結果：急性冠症候群の診断遅延

「権威ある情報源」がアンカーの強度を増幅

年間約 27,000 件の入院と 150,000 件以上の患者被害が診断エラーに起因

利用可能性ヒューリスティック — 思い出しやすい=よくある？

臨床ケース：直近の経験が判断を歪める

先週、肺炎を見逃して急変させた研修医が翌週の外来で——

1. 利用可能性の増大：「肺炎を見逃した」記憶が鮮烈に残る
2. 確率推定の歪み：咳嗽・発熱の患者で肺炎の事前確率を過大評価
3. 過剰検査：臨床的に不要な CT オーダーの増加
4. 逆方向のリスク：肺炎に注意が集中し、心不全や喘息発作を見落とす

1,015 名調査：利用可能性ヒューリスティックが診断推論に系統的影響を実証

過信 — 自分の判断を過大評価する

過精度

信頼区間が狭すぎる
「90% 確実」が実際は 60%

過大評価

自分の能力を
実際以上に見積もる

過配置

自分が平均以上
だと信じる

時期	自信	正確性	状態
研修初期	高い	低い	「知らないことを知らない」
中間期	急落	上昇中	複雑さに気づく
熟達期	適切	高い	自信と謙虚さのバランス

逆転現象：レジデントは指導医より自信が高いのに正確性は低い

除偏介入の実践 — あなたの脳を守る 3 つの武器

1. 診断タイムアウト

意図的に立ち止まり
「他に何があり得るか？」と自問
Crookerry (2003) 認知的強制戦略

2. プレモーテム分析

「もしこの診断が間違っていたら
最も可能性の高い理由は？」
Gary Klein 提唱

3. 構造化振り返り

自分の推論プロセスを検討する
「認知的剖検（Cognitive Autopsy）」
唯一成功が確認された介入

テクノロジー介入 87.9% 成功 vs 認知的戦略 50.0% (Ludolph & Schulz 2018)

ペアワーク — 構造化振り返りをやってみよう（5 分）

最近の診療で診断に迷った症例を 1 つ思い出し、以下の 4 つの問いに答える：

#	問い	対応バイアス
1	最初の診断仮説は何？ いつ形成された？	アンカリング
2	仮説を支持する情報ばかり集めていなかった？	確認バイアス
3	最近の経験が判断に影響していなかった？	利用可能性
4	どれくらい確信していた？ その根拠は？	過信

パートナーに「もしその診断が間違っていたら？」
と聞いてもらう（プレモーテム分析の実践）

AI× バイアス ＋ 持ち帰りの問い

AI 機能	バイアス増幅リスク	緩和ポテンシャル
診断候補の提示	アンカリング強化	鑑別の網羅性向上
確率推定	過信の技術的増幅	ベースレート想起の自動化
パターン認識	確認バイアスの自動化	見逃しパターンの検出

明日の診療で試してほしいこと：

1. 診断タイムアウト：1 日 1 回「他に何があり得るか？」と自問する
2. バイアス日誌：今週 1 例、4 つの問いで推論を振り返る

バイアスは個人の失敗ではない。認識することがメタ認知能力の高さを示す。